



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : عزه محمد امام محمد
المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : الساحل
رقم البطاقة : 27108100104641 رقم التليفون : 01555305448
العنوان : شعيب
العمر (تاريخ الميلاد) : 10-08-1971 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 22-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبتات
الاروماتيز [14161]
قسم العلاج :
الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: عزه محمد امام محمد National ID: 27108100104641	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



عزہ
محمد امام محمد یونس
٧ درب شعيب - دایر الناحیه
الساحل - القاهره

١٩٧١/٠٨
٢٧١٠٨١٠٠١٠٤٦٤١

LA6418112

[illegible]

১৯৮০
 ১৯৮১
 ১৯৮২
 ১৯৮৩
 ১৯৮৪
 ১৯৮৫
 ১৯৮৬
 ১৯৮৭
 ১৯৮৮
 ১৯৮৯
 ১৯৯০
 ১৯৯১
 ১৯৯২
 ১৯৯৩
 ১৯৯৪
 ১৯৯৫
 ১৯৯৬
 ১৯৯৭
 ১৯৯৮
 ১৯৯৯
 ২০০০
 ২০০১
 ২০০২
 ২০০৩
 ২০০৪
 ২০০৫
 ২০০৬
 ২০০৭
 ২০০৮
 ২০০৯
 ২০১০
 ২০১১
 ২০১২
 ২০১৩
 ২০১৪
 ২০১৫
 ২০১৬
 ২০১৭
 ২০১৮
 ২০১৯
 ২০২০
 ২০২১
 ২০২২
 ২০২৩
 ২০২৪
 ২০২৫
 ২০২৬
 ২০২৭
 ২০২৮
 ২০২৯
 ২০৩০
 ২০৩১
 ২০৩২
 ২০৩৩
 ২০৩৪
 ২০৩৫
 ২০৩৬
 ২০৩৭
 ২০৩৮
 ২০৩৯
 ২০৪০
 ২০৪১
 ২০৪২
 ২০৪৩
 ২০৪৪
 ২০৪৫
 ২০৪৬
 ২০৪৭
 ২০৪৮
 ২০৪৯
 ২০৫০

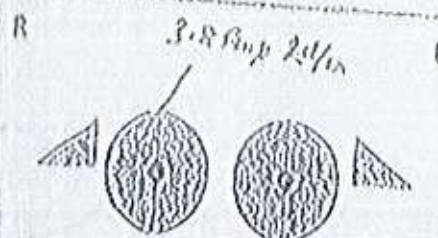
MDT FORM

15/7/2025 G

MDI FORM		15/7/2025 G	
Name	Full name	MRN	1779
Age	55y.	IR	2025
Menopausal status	Post-menopausal	Phone	01200861079
NRS SCORE		Marital status	widow
BMI		Family history	is unknown
CO morbidity	included	REASON OF MDI	New Case
		CVV A111. 8781	

Clinical Data

DX: Rt. I.D.C. 6.11
 ER: 8/8 PRI 6/8 HER 2/1 K1671
 Sonomammography: 25%
 Rt. U.O. @ palpable malignant
 looking solid lesion between
 Mot. Working Core 9-10 o'clock.
 enlarged one pathological axilla
 L. Ns 15x13mm



C.T.N.M.

Q. 18. Extract -> Point located lower than ground
Recommendations: glassy mostly gravitational.

Rt

۱۰۰

1417 Bond

MOT OUTCOME & PLAN (C) Claps inserted

(2) SO_2 3 eq. NaOAc (NACl)

③ $\text{PbS} \downarrow \text{SLNB (or, AlNO)}$

SIGNATURE

SIGNATURE					
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
15171243	15171243	15171243	15171243	15171243	15171243



MINISTRY OF HEALTH
SUDAN

قسم الأمراض

قسم الأمراض
قسم الأمراض
قسم الأمراض

PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: **د. محمد عبد الرحمن**

Request type: **مباردة**

Hospital no: **مستشفى البراءة**

Department:

Referred by: **د. محمد عبد الرحمن**

Nature of specimen: **True Cut Biopsy**

Clinical diagnosis: **Right breast malignant 1003m solid Mass.**

Gross pathology:

Multiple grayish white tissue cores up to 1.8cm. or 2, totally submitted.

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view IRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections were treated against: ER- PR- Her2- Ki67

Microscopic picture:

Section examined revealed mammary core tissue showed malignant growth formed of the tumor form, clusters, nest, tubules of anaplastic ductal cells with moderate anaplasia and moderate tendency to form tubules dispersed among desmoplastic stroma. There is ductal carcinoma in situ component could be seen of intermediate grade, solid sub type. There is mild lymphocytes infiltrate. There is no evident lymph vascular tumor emboli invasion or perineural infiltration in core tissue examined.

ER: Strong positive nuclear staining of 80 % tumor cells (Allred Score 8/8).
PR: Moderate positive nuclear staining of 40% tumor cells (Allred Score 6/8).

Her2: Weak incomplete membranous staining in more than 10 % of tumor cells, Score (1+)
Ki67: Positive nuclear staining in 25% of tumor cells.

Diagnosis: **Right Breast Mass, True Cut Biopsy:**

Invasive Ductal Carcinoma (NST), grade II,

(ER: 8/8), (PR: 6/8), (Her2: Score 1+), (Ki67: 25%)

Signature:

Dr. Nermin Nabil, M.D.

Dr. Mona Mohamed, M.D.

Pathology Lab. Manager

Nermin Nabil, M.D.

د. محمد عبد الرحمن
د. محمد عبد الرحمن
د. محمد عبد الرحمن
د. محمد عبد الرحمن
د. محمد عبد الرحمن



الجمهورية العربية السودانية
الوزارة الصحية
مركز البحوث الطبية

الوزارة الصحية السودانية
مركز البحوث الطبية
مركز البحوث الطبية

PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient Name: محمد اسماعيل محمد

Request type: روتين

Hospital no: 100100104641

Department:

Referred by: دكتور د. حسن

Nature of specimen: True Cut Biopsy

Clinical diagnosis: Right breast malignant 100gm solid Mass.

Gross pathology:

Multiple grayish white tissue cores up to 1.8cm. or 2, totally submitted.

Immunohistochemical Technology:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view URP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: ER- PR- Her2- Ki67

Microscopic picture:

Section examined received in paraffin core tissue showed malignant growth formed of the tumor form clusters, nest, tubules of malignant ductal cells with moderate atypia and moderate tendency to form tubules dispersed among desmoplastic stroma. There is ductal carcinoma in situ component could be seen of intermediate grade, solid sub type. There is mild lymphocytes infiltrate. There is no evident lymph vascular tumor emboli invasion or perineural infiltration in core tissue examined.

ER: Strong positive nuclear staining of 80% tumor cells (Allred Score 8/8).

PR: Moderate positive nuclear staining of 40% tumor cells (Allred Score 6/8).

Her2: Weak incomplete membranous staining in more than 10% of tumor cells, Score (1+)

Ki67: Positive nuclear staining in 25% of tumor cells.

Diagnosis: Right Breast Mass, True Cut Biopsy;

Invasive Ductal Carcinoma (NST), Grade II.

ER: 8/8, PR: 6/8, Her2: Score 1+, Ki67: 25%.

Signature:

Dr. Nermine Nabil, M.D.

Dr. Mona Mohamed, M.D.

Pathology Lab. Manager:

Nermine Nabil, M.D.

Handwritten signature and stamp of the Pathology Lab. Manager.



Mrs. Azza Mohamed
Date: 21/08/20

Digitalized Mammography and Complementary
Ultrasonography for Both Breasts Revealed:
Clinical Summary:

Right breast palpable lump from two weeks

Findings:

• Right breast

• fatty dense mammary parenchyma; ACRb

• UOQ well defined irregular dense lesion with distortion

• US examination depicted irregular hypochoic solid lesion seen between 9-10 o'clock zone c. It measures 38x24mm, away from nipple by 6 cm and skin 7mm. It shows penetrating blood vessels by color Doppler

• Normal skin thickness and contour.

• Enlarged one pathological axillary L.N. It measures 15x13mm. It shows loss fatty hilum.

• Left breast

• fatty dense mammary parenchyma; ACRb

• No dense mass lesion, asymmetrical density or distortion identified.

• Ultrasonography examination shows no cyst or solid lesion

• Normal skin thickness and contour.

• Few non specific axillary L.Ns are noted.

• Impression:

Right breast (BIRADS 5) UOQ palpable malignant looking solid lesion, for biopsy

Left breast (BIRADS 1). normal study

Much obliged
Dr. Manwa M. Hassan

ملحق 3901: دراسة التصوير الشعاعي للثديين. الثدي الأيمن: كتلة كثيفة غير منتظمة الشكل، 3.8x2.4 سم، على بعد 6 سم من الحلمة و7 مم من الجلد. تظهر أوعية دموية متغلغلة على دوبلر اللون. الثدي الأيسر: طبيعي. العقد الليمفاوية الإبطية: تضخم عقدة واحدة 1.5x1.3 سم مع فقدان النخلة الدهنية. النتائج: الثدي الأيمن (BIRADS 5) - كتلة مشبوهة بالسرطان، تحتاج خزعة. الثدي الأيسر (BIRADS 1) - طبيعي.

GUSTAVI/
ROUSSY

Patient Name: Hala Abd Allah Khaled Al
Seadezy

Date: 25/08/2025

Exam: CT chest

Age: 18 Year(s)

Medical ID: 2611/2022

Pat ID: 20043

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF ABDOMEN AND PELVIS:

Compared to the previous study dated 19/3/2025 the
current study shows:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or biliary radicles dilatation, on non-contrast basis.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- No enlarged abdominal or pelvic gross lymphadenopathy.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Examined skeleton
- Still noted right sternal angle lytic lesion at site of 2nd rib articulation
- Still noted left sterno-clavicular joint and proximal anterior aspect of first rib lytic lesions with extra-osseous soft tissue component eroding the adjacent sternum surrounded by mild sclerosis.
- Still noted L5 1st degree lytic spondylolisthesis.

Conclusion

Follow up study allowed

Rather stationary course as regards the previous study.

Signature Dr. Hasmán Rámadán

16/07/2025 1:30 PM